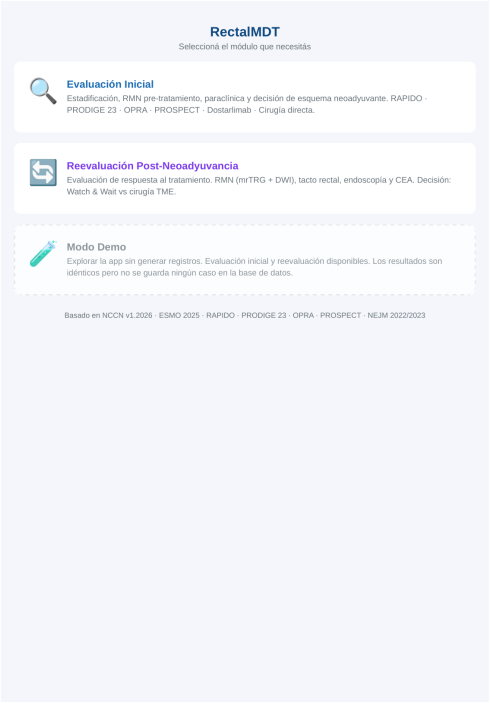
Manual de uso

RectalMDT

Guía práctica para completar formularios, interpretar la información que devuelve la app, usar los registros y enviar feedback.



Pantalla de inicio de RectalMDT.

Este manual cubre

- Pantalla de inicio y módulos disponibles.
- Cómo completar la evaluación inicial.
- Cómo completar la reevaluación post-neoadyuvancia.
- Qué información devuelve la app.
- Cómo funcionan los registros y el botón de feedback.

1. Qué hace la app

RectalMDT es una herramienta de soporte para discusión en MDT en cáncer de recto. La app organiza los datos clínicos, radiológicos y endoscópicos, genera una recomendación orientativa y permite registrar lo decidido por el equipo.

Módulos principales

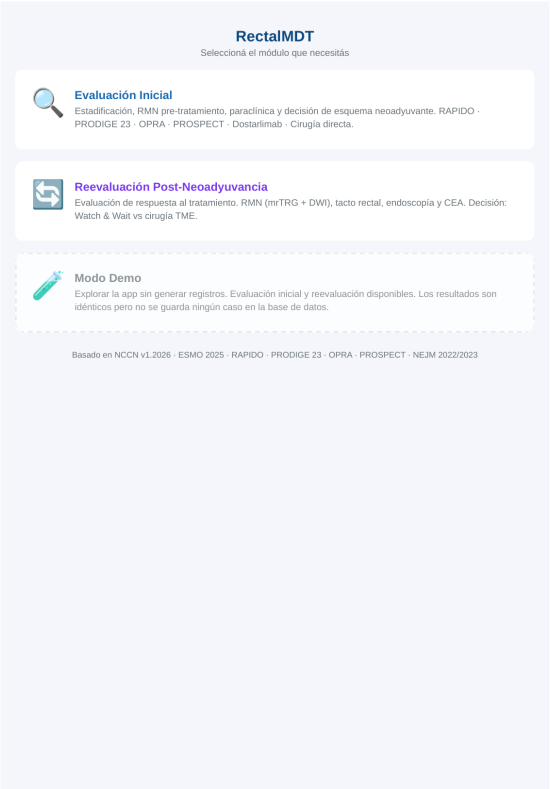
Evaluación inicial: orienta la decisión del esquema inicial a partir de estadificación, RMN pretratamiento y factores clínicos.

Reevaluación post-neoadyuvancia: integra RMN, DRE, endoscopía, biopsia y contexto terapéutico para orientar la conducta posterior.

Modo demo: permite explorar la app sin guardar registros.

2. Pantalla de inicio

Al abrir la app, aparecen tres accesos principales. Elegí el que corresponda según el momento del paciente.



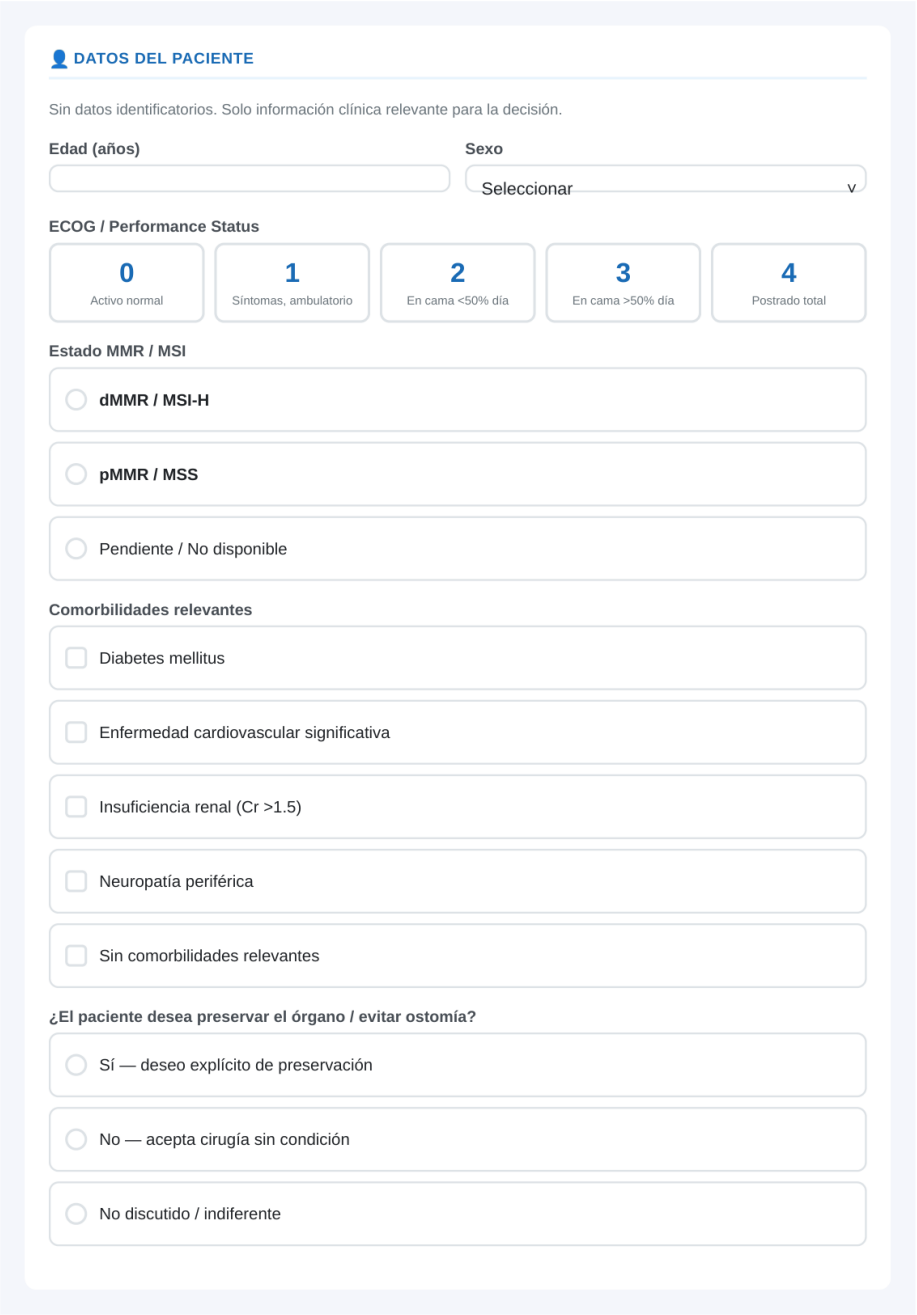
Inicio: Evaluación inicial, Reevaluación post-neoadyuvancia y Modo demo.

3. Evaluación inicial: cómo llenar el formulario

Este módulo se usa antes del tratamiento. La lógica práctica es completar la información por bloques, avanzar y luego analizar.

3.1 Datos del paciente

Completá edad, sexo, ECOG, estado MMR/MSI, comorbilidades y objetivo del paciente respecto a preservación de órgano. Estos campos contextualizan intensidad de tratamiento, factibilidad de estrategias de preservación y elegibilidad de algunas rutas terapéuticas.



Bloque 1: datos del paciente.

Cómo interpretar este bloque

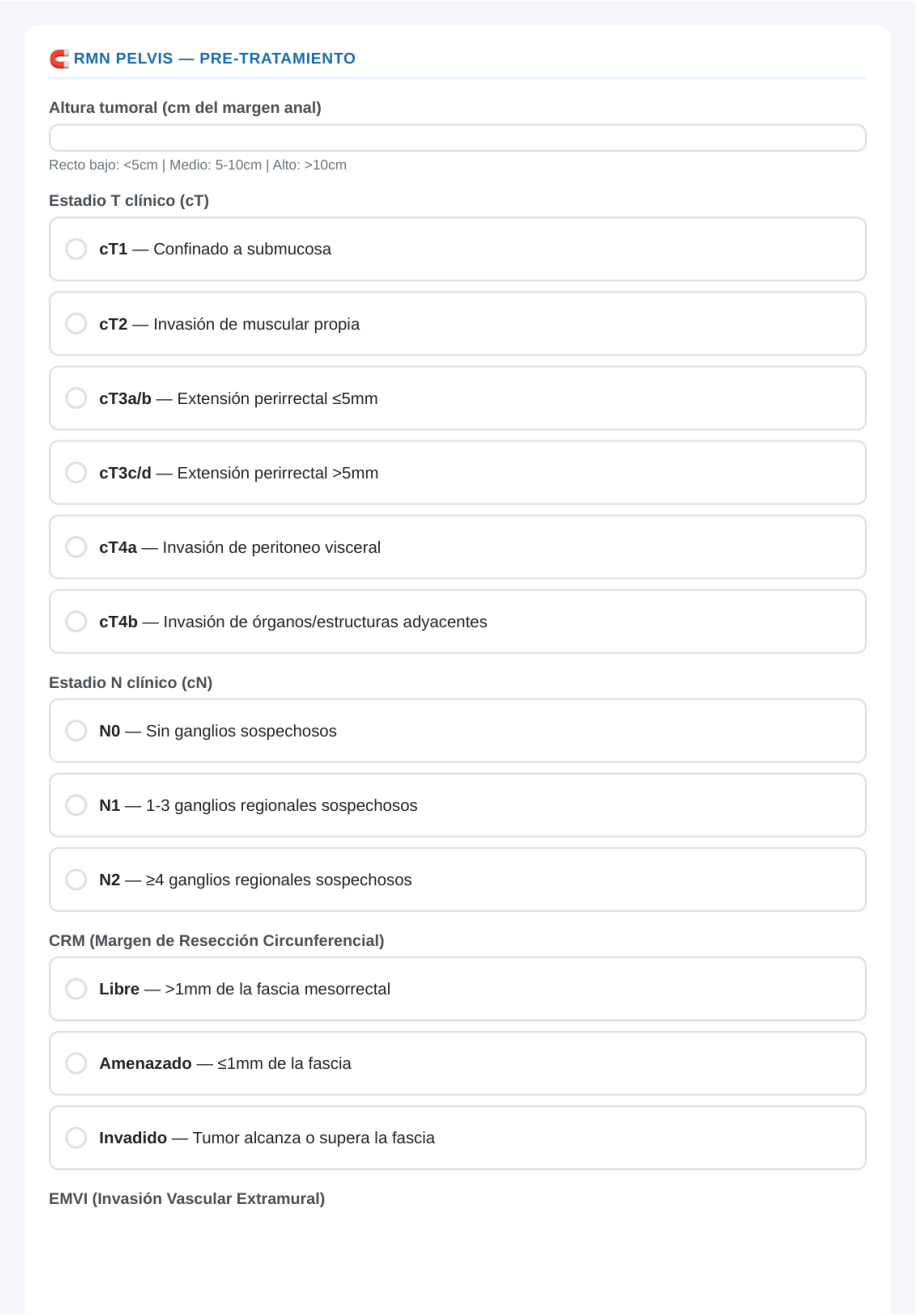
• **ECOG:** resume estado funcional. Si el paciente tiene ECOG 2, la app pide aclarar si se debe al tumor, a comorbilidades o si es mixto.

• **MMR/MSI:** identifica si el caso es dMMR/MSI-H, pMMR/MSS o pendiente.

• **Deseo de preservación:** deja registrado si existe un objetivo explícito de evitar ostomía o preservar órgano.

3.2 RMN pelvis pre-tratamiento

Ingresá altura tumoral, cT, cN, CRM y EMVI. Este bloque concentra el núcleo de la estadificación local.



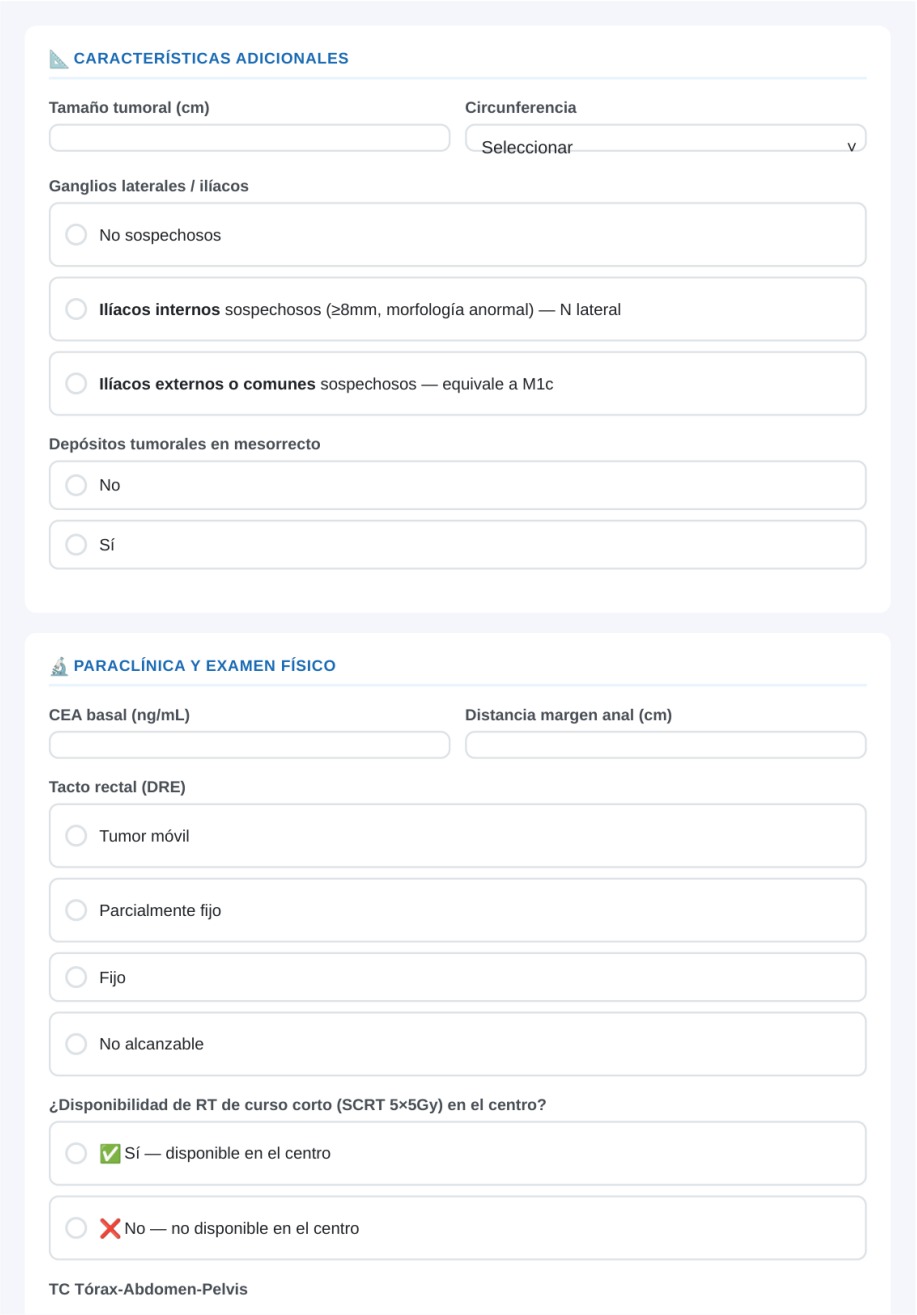
Bloque 2: RMN pelvis pre-tratamiento.

Qué informa este bloque

- **Altura tumoral:** ubica el tumor en recto bajo/medio/alto según distancia al margen anal.
- **cT y cN:** reflejan extensión tumoral y compromiso ganglionar clínico.
- **CRM:** distingue margen libre, amenazado o invadido.
- **EMVI:** registra invasión vascular extramural.

3.3 Características adicionales y examen físico

Aquí se completa tamaño tumoral, circunferencia, ganglios laterales, depósitos tumorales, CEA, tacto rectal, disponibilidad de SCRT y TC TAP. Sumá observaciones si querés dejar alguna aclaración clínica.



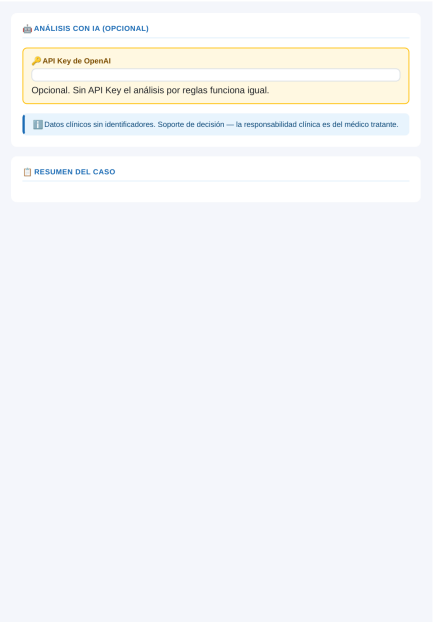
Bloque 3: características adicionales, examen físico y disponibilidad de RT corta.

Consejo de carga

Usá este espacio para capturar información que cambia la lectura del caso: ganglios laterales sospechosos, fijación al tacto, ausencia de SCRT en el centro, o hallazgos no reflejados en los campos cerrados.

3.4 Análisis con IA (opcional)

La API key es opcional. Si no se ingresa, el motor principal de la app sigue funcionando igual; simplemente no se agrega el comentario de IA.



Bloque 4: API key opcional y resumen del caso.

4. Qué devuelve la evaluación inicial

Salida esperable

La app resume el caso y devuelve una **recomendación de la app**. Además, muestra **preguntas clave para el MDT** y, si se configuró API key, un bloque de **análisis IA**.

Luego podés registrar si el MDT estuvo de acuerdo con la recomendación, qué tratamiento decidió y, si hubo discordancia, cuál fue el motivo.

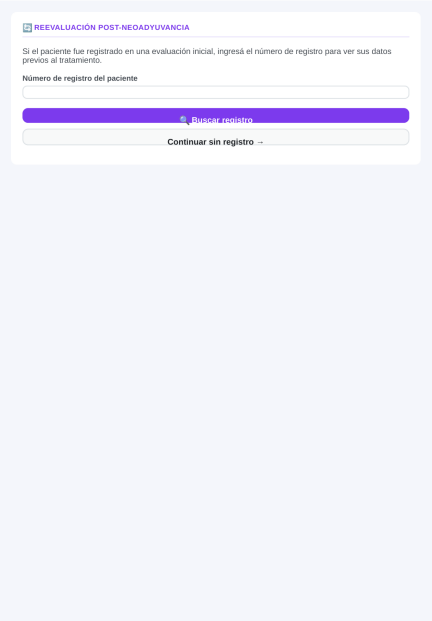
En términos prácticos, la salida no reemplaza la discusión clínica: organiza el caso, transparenta los factores que pesan en la decisión y deja trazabilidad de lo decidido por el equipo.

5. Reevaluación post-neoadyuvancia

Este módulo se usa después del tratamiento neoadyuvante. Puede iniciarse buscando un registro previo o continuar sin registro.

5.1 Búsqueda de registro

Si el paciente ya tuvo una evaluación inicial cargada, ingresá el número de registro y tocá “Buscar registro”. Si no existe registro previo o querés explorar el módulo, podés continuar sin registro.

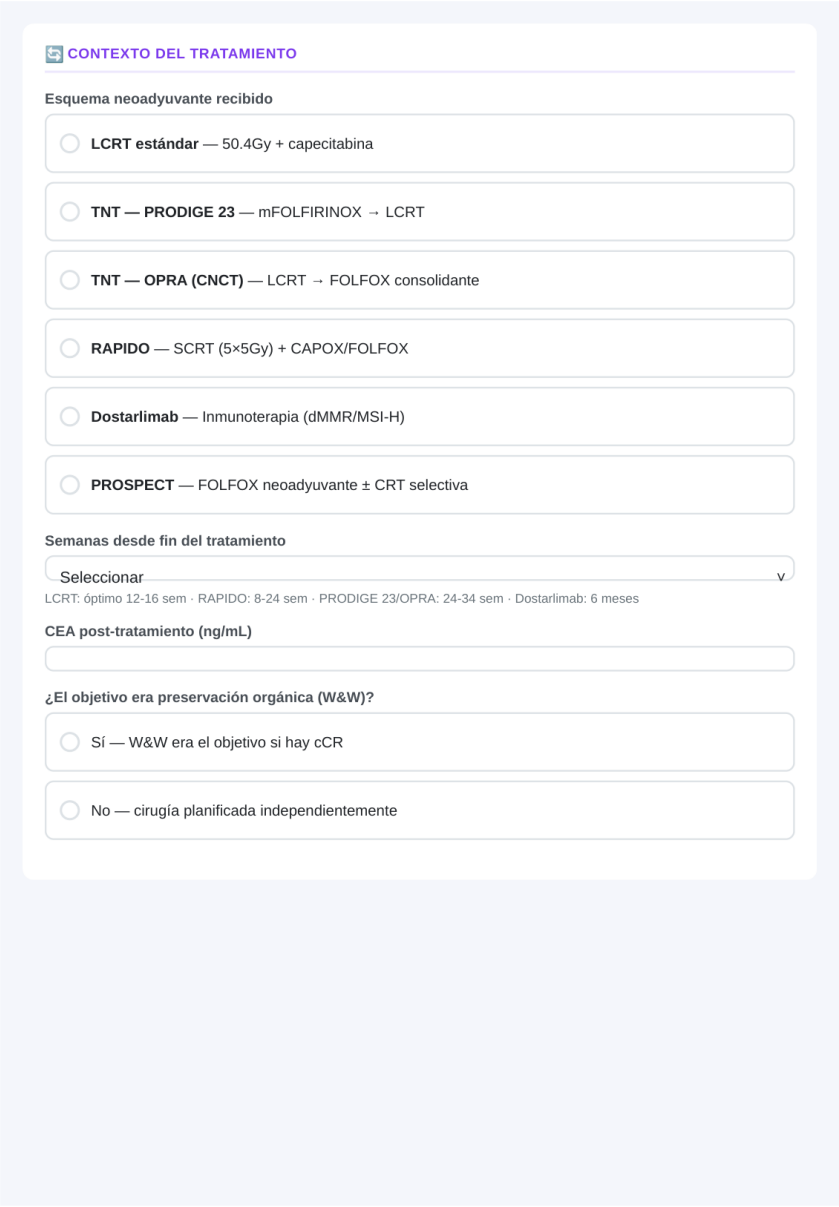


Entrada al módulo de reevaluación.

> **Importante**
>
> Cuando existe un registro previo, la app recupera información basal del caso y la usa como contexto de la reevaluación.

5.2 Contexto del tratamiento recibido

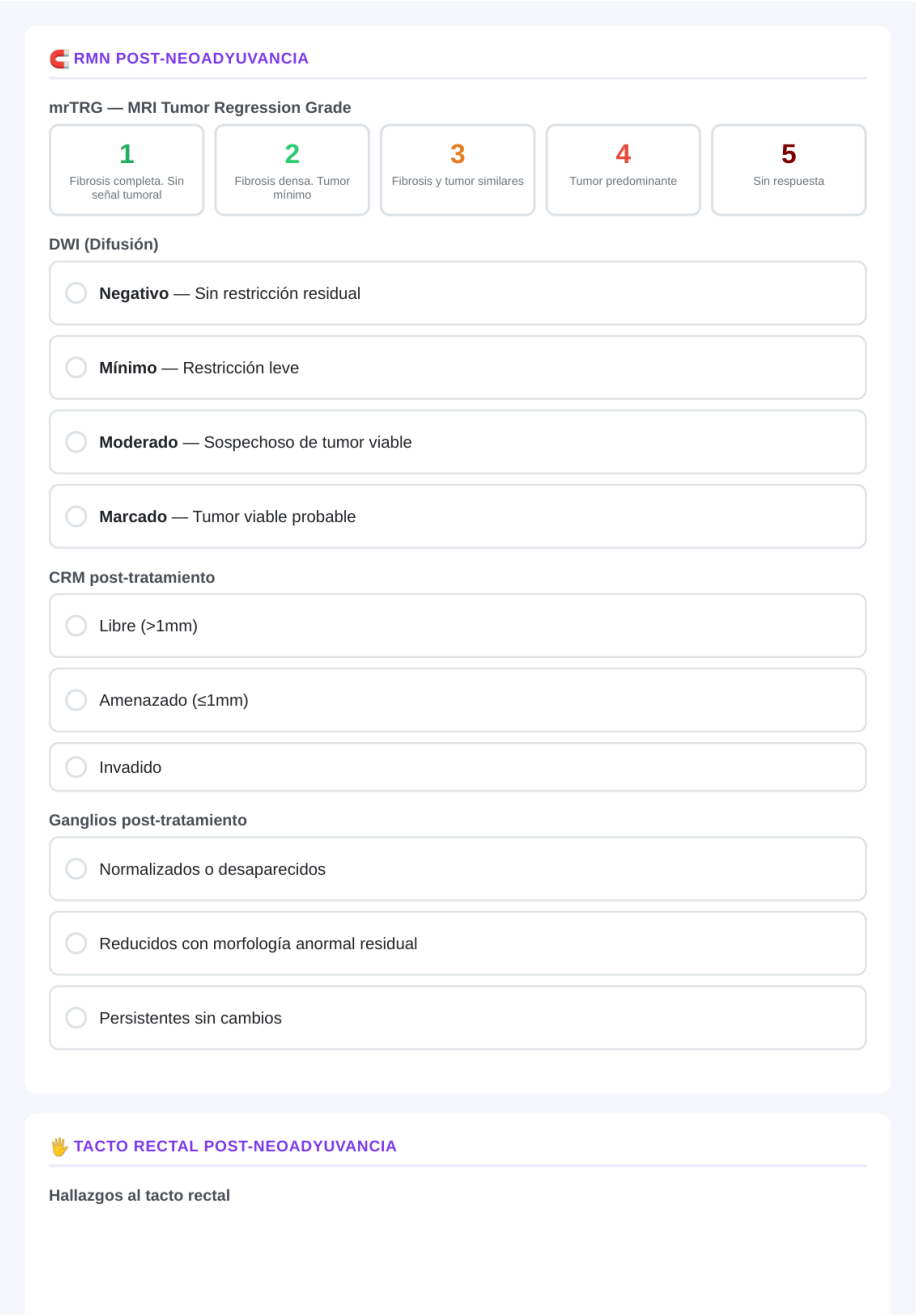
Elegí el esquema efectivamente administrado, el intervalo desde el fin del tratamiento y si el objetivo era preservación orgánica. Si el tratamiento recibido no coincide con el recomendado originalmente, la app permite registrar el motivo.



Bloque 1 de reevaluación: contexto del tratamiento recibido.

5.3 RMN post-neoadyuvancia

Completá mrTRG, DWI, CRM post-tratamiento y ganglios post-tratamiento. Este bloque resume la respuesta radiológica.



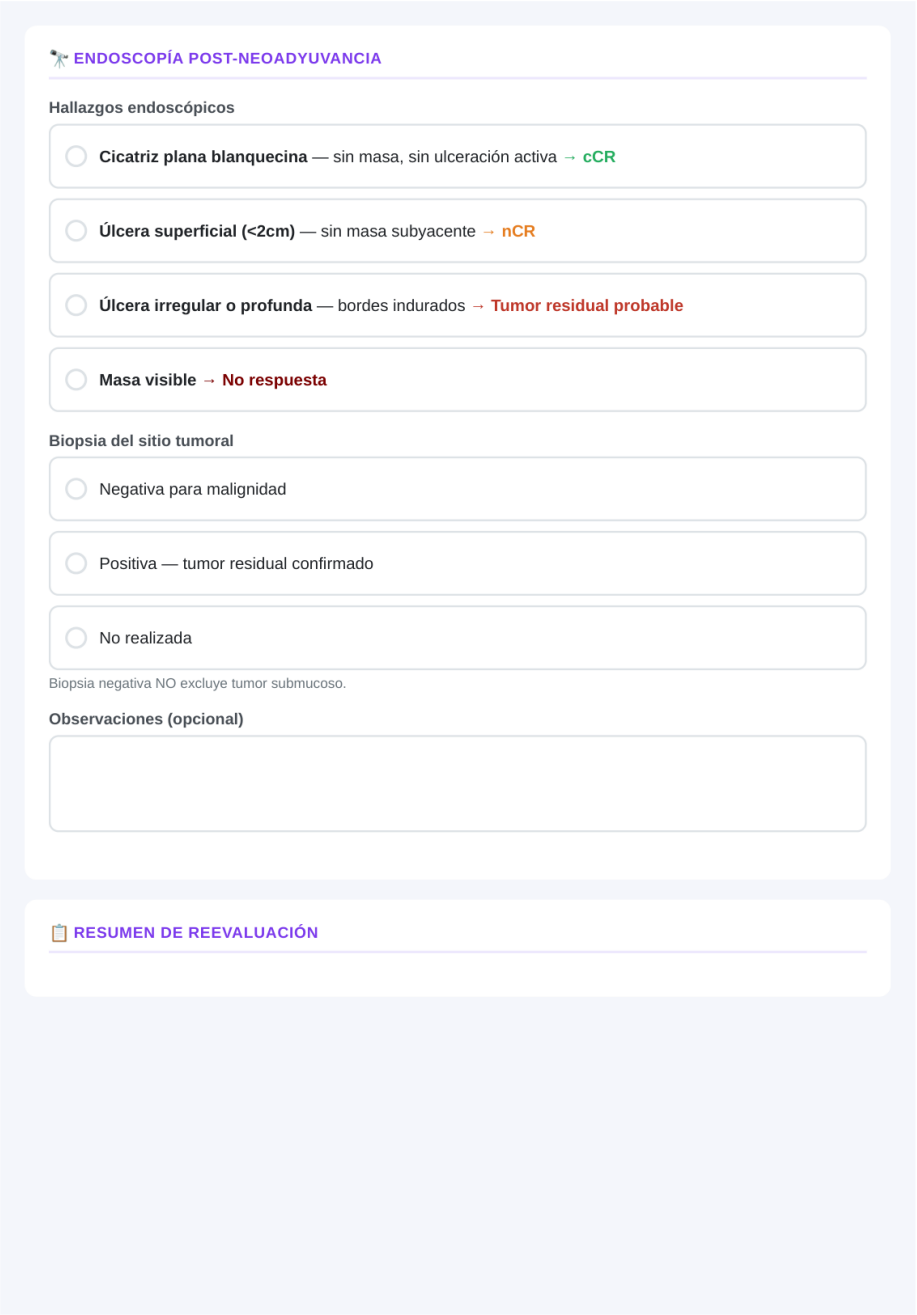
Bloque 2: RMN post-neoadyuvancia y tacto rectal.

Qué informan estas respuestas

- **mrTRG:** expresa el grado de regresión tumoral por RMN.
- **DWI:** resume si hay o no restricción residual.
- **CRM post:** informa si el margen queda libre, amenazado o invadido.
- **DRE:** agrega correlato clínico de la respuesta.

5.4 Endoscopía, biopsia y observaciones

En este bloque se integran hallazgos endoscópicos, biopsia del sitio tumoral y observaciones adicionales. Es la parte que ayuda a distinguir respuesta completa clínica, respuesta casi completa o persistencia tumoral.



Bloque 3: endoscopía, biopsia y resumen de reevaluación.

6. Qué devuelve la reevaluación

Salida esperable

La app entrega una **recomendación orientativa de conducta** después de la neoadyuvancia, integrando RMN, DRE, endoscopía, biopsia y contexto del tratamiento.

En la práctica, la salida ayuda a ordenar la discusión entre estrategias como seguimiento tipo Watch & Wait versus cirugía/TME, siempre como soporte para la decisión del MDT.

La reevaluación también puede exportarse y quedar asociada al registro del caso cuando corresponde.

7. Registros: para qué sirven y cómo leerlos

Cada vez que se guarda un caso, la app genera un número de registro único. Ese número permite buscar el caso en reevaluación y mantener continuidad documental entre módulos.

Formato general del registro

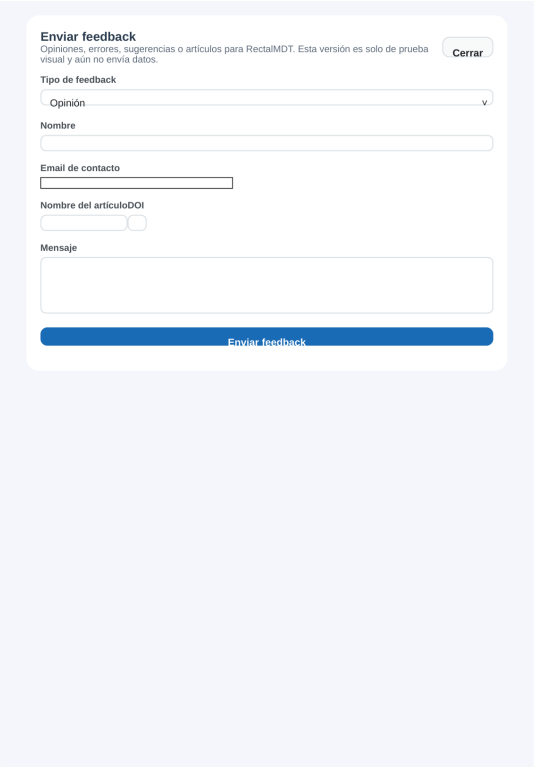
URY-**CENTRO-AAAAMMDD-SECUENCIA**

Ejemplo: el prefijo del centro cambia según la sede seleccionada. Entre las opciones disponibles ya está incluido **SMI** junto con Clínicas, Maciel, INCA y Centro Piloto.

El campo “¿El MDT decidió el tratamiento recomendado por la app?” sirve para comparar recomendación automática y decisión real del equipo. Si no coincide, se registra el motivo de discordancia.

8. Botón de feedback

El botón flotante de feedback está disponible para enviar opiniones, reportes de error, sugerencias o artículos. También puede usarse para informar referencias nuevas con nombre del artículo y DOI.



Formulario de feedback.

Qué conviene enviar por feedback

- **Opinión:** comentarios generales de uso.
- **Error:** bugs, campos que no responden o salidas inesperadas.
- **Sugerencia:** mejoras de flujo, claridad o campos nuevos.
- **Artículo:** nombre del trabajo, DOI y comentario sobre por qué debería considerarse.

El feedback queda asociado al sistema y permite mejorar la app sin necesidad de modificar el registro clínico del paciente.

9. Modo demo y exportación

Modo demo sirve para practicar o mostrar la herramienta sin guardar ningún caso. La opción de exportar/descargar permite generar un documento del resultado para compartir o archivar.

Diferencia clave

Modo normal: puede generar y buscar registros.

Modo demo: reproduce el flujo, pero no guarda casos en la base.

10. Recomendaciones prácticas de uso

- Verificá primero si el paciente ya tiene número de registro antes de cargar una reevaluación.
- Completá la RMN y el examen físico con el mayor nivel de precisión disponible; son los bloques que más cambian la orientación de la app.
- Usá observaciones para aclarar matices que no entren bien en los campos cerrados.
- Registrá siempre la concordancia o discordancia del MDT para preservar trazabilidad.
- Usá feedback cuando detectes un error o quieras sugerir una mejora; no hace falta alterar el registro clínico para reportarlo.

Nota final

Este manual es operativo: explica cómo usar la app y qué significa cada bloque dentro del flujo de trabajo. La decisión final sigue siendo clínica y corresponde al MDT.